

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS EM SAÚDE

Christiano Braga de Castro Lopes



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Fontes de fornecimento e abastecimento

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar as fontes de fornecimento e abastecimento para o setor da saúde.
- Descrever as principais características para realizar a seleção de fornecedores.
- Formular aspectos relevantes para a realização da avaliação de fornecedores.

Introdução

Neste capítulo, você vai estudar as fontes de fornecimento e abastecimento que as instituições de saúde têm à disposição. Também vai ver o relacionamento que a cadeia de suprimentos precisa ter com essas fontes para assegurar que os materiais médico-hospitalares e os demais insumos sejam entregues em conformidade com a ordem de compras ou empenho, no caso das instituições públicas de saúde.

Tais fontes são selecionadas pelo setor de suprimentos com o objetivo de compor uma cadeia de suprimentos adequada à instituição. Nessa seleção, as relações de parceria com fornecedores são de grande importância. Também são importantes alguns critérios utilizados para avaliar os fornecedores, visando sempre ao desenvolvimento de uma cadeia potencialmente viável e sustentável do ponto de vista financeiro, logístico e da gestão de riscos para as instituições de saúde.

1 Conceito

Para você, o que seriam fontes de fornecimento e abastecimento? Tente imaginar uma instituição de saúde e as demandas necessárias para atender aos seus clientes. O cliente é o paciente ou um acompanhante que buscam os serviços de saúde, que, por sua vez, oferta cuidados por meio de seus profissionais, medicamentos e correlatos. Essa é a resposta que vem logo à nossa mente; no entanto, a cadeia de suprimentos não depende apenas de medicamentos, mas de diversos outros insumos necessários aos serviços de apoio às áreas assistenciais dessas instituições de saúde.

Em um hospital, por exemplo, além dos medicamentos, é necessário material médico hospitalar e biomédicos, materiais de diagnóstico, material de manutenção, gases medicinais, equipamentos de proteção individual, nutrição, materiais de limpeza e higiene, material de expediente, descartáveis, reagentes químicos e instrumentais cirúrgicos. Você consegue perceber o desafio da cadeia de suprimentos na busca das fontes de fornecimento e abastecimento?

Antes de você conhecer algumas fontes de fornecimento, é importante compreender que elas variam de acordo com alguns fatores, a exemplo da demanda. Para Barbieri e Machline (2017, p. 92), “[...] qualquer variação da demanda ou das condições de fornecimento gera problemas de falta ou de excesso”. Se uma instituição de saúde tem uma alta demanda de determinado item, a decisão sobre a escolha da fonte de fornecimento e abastecimento deverá levar em consideração esse fator, pois o tempo de entrega pode influenciar no resultado final. Podemos citar ainda outros fatores, como transporte, distância e custos.

Analise a recomendação dada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em uma de suas fiscalizações acerca do tema:

Determinar [...] planejamento das aquisições de medicamentos, de modo a integrar a política de assistência farmacêutica ao ciclo orçamentário anual, devendo levar em consideração os prazos, a anualidade do orçamento, sua utilidade como planejamento da administração pública, os já conhecidos e, portanto, esperados entraves (distâncias, tempo médio de esperas, itens com histórica baixa atratividade, costumeiramente ensejadores de licitações desertas ou fracassadas ou tradicionalmente adquiridos via compras diretas etc.); viabilidade de cooperação com outros entes federados, em novas iniciativas ou aproveitamento de outras eventualmente existentes, para aquisição de medicamentos, especialmente considerando as alegadas dificuldades de atendimento da Região Norte; estudos de novas soluções para superação dos problemas mencionados de desinteresse de fornecedores para transações com o governo, em particular com entes da Região Norte, tendo em vista que em muitos casos o Estado é o único ou principal cliente de determinados itens, sobretudo de atendimento de alta complexidade (BRASIL, 2019b).

A distância entre as cidades e a prevalência do modal de transporte rodoviário, no Brasil, é um dos desafios da cadeia de suprimentos no processo de identificação das fontes de fornecimento e abastecimento nas instituições de saúde, sejam públicas, sejam privadas. É comum nos depararmos com variações de mercado que necessitam ser analisadas antes de definirmos a fonte de fornecimento — por exemplo, é possível encontrar a dipirona sódica 500 mg comercializada por R\$ 0,06 no município de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, e por R\$ 0,18 em Araraquara, no Estado de São Paulo. São duas cidades separadas por pouco mais de 500 km; dependendo da quantidade a ser adquirida e da localização da instituição compradora, a decisão de comprar de uma cidade ou outra pode representar uma redução nos custos de aquisição.

Tipos de fontes de fornecimento e abastecimento

Assim, podemos começar a compreender quais são as fontes de fornecimento e abastecimento viáveis que a cadeia de suprimentos precisa levar em consideração no momento de contratar ou adquirir determinado produto no mercado da saúde, até por que, como você viu, o Brasil é um país com dimensões continentais e com a prevalência do modal de transporte rodoviário. A **logística de suprimentos** é a responsável por suprir as demandas da instituição, providenciando os insumos necessários para o usuário final. Normalmente, envolve as áreas de compras e gestão de estoques.

A **logística reversa** está diretamente relacionada com os critérios de sustentabilidade, por valorizar os resíduos do pós-venda e do pós-consumo, fazendo ou facilitando o seu retorno às fábricas de origem ou promovendo o descarte apropriado. Mas o que seria a logística reversa? A logística reversa é, basicamente, o fluxo reverso da cadeia de suprimentos. Na logística reversa, quem entrega o produto é o cliente, e não o produtor ou fabricante. “A existência da conectividade direta entre o consumidor final e o fabricante do produto facilita a resolução rápida dos problemas de atendimento ao cliente, relacionados ao uso e à garantia do produto” (BOWERSOX *et al.*, 2014, p. 15). Assim, a logística reversa tem a função de evitar ou minimizar a degradação do meio ambiente por meio da conscientização das empresas e de toda a sociedade.

A **logística de apoio à manufatura** é aquela que trabalha com um planejamento de demanda, de giro e cobertura de estoque, custos, tempos de reposição para que, em seguida, possa analisar a capacidade de armazenamento e, finalmente, operar os fluxos internos da instituição, a exemplo das dispensações, pagamentos, entre outros. Acerca do tema, analise o que recomenda o TCU:

Obter, previamente, as informações/demandas junto aos hospitais federais, concomitante às licitações unificadas em curso [...], com vistas a realizar planejamento antecipado de licitações unificadas pontuais, a fim de possibilitar a adesão às Atas de Registro de Preços pelas demais unidades, evitando a renovação anual dos contratos em curso derivados de licitações próprias (BRASIL, 2019a).

Diante do excerto do Acórdão nº. 13053, de 3 de dezembro de 2019, fica clara a importância de um planejamento antecipado visando à escolha de uma fonte de fornecimento? Planejar uma licitação unificada pode representar uma redução de custos exponencial, tendo em vista o montante da demanda envolvida e o potencial interesse dos fornecedores.

A **logística de distribuição** é aquela relacionada à entrega de pedidos, transportes, frentes e custos logísticos relacionados. “Estabelecer antecipadamente modos alternativos de entrega é a contramedida mais óbvia com relação a paralisações derivadas de greves, desastres naturais [...]” (BALLOU, 2006, p. 114); no entanto, para assegurar esses planos preventivos e de contingências, a cadeia de suprimentos poderá absorver custos adicionais.

A logística de distribuição envolve, basicamente, transportadoras que são contratadas para realizar as entregas de um ponto de origem ao ponto de destino, por meio do modal adequado, mediante o pagamento de taxas e encargos. Por fim, a logística reversa é responsável por fornecer produtos mediante o retorno ou devolução de determinada matéria-prima. As instituições de saúde vêm, atualmente, investindo muito nessas alternativas com as fontes de fornecimento e abastecimento, a exemplo da devolução de materiais médicos e medicamentos próximos de seus vencimentos, ou ainda, cartas de crédito por perda de validade.

Como você pode perceber, as fontes de fornecimento e abastecimento constituem uma atividade estratégica para as instituições de saúde, intimamente relacionada com a gestão de riscos e com a gestão de custos, pois definir a fonte de fornecimento correta pode mitigar riscos no desabastecimento dos insumos necessários para garantir a segurança do paciente. Essas fontes de fornecimento são fundamentais para a cadeia de suprimentos na tomada de decisões e, por isso, elas precisam se apresentar na forma de parceiros comerciais, compartilhando riscos, custos e resultados.

2 Seleção e homologação de fornecedores

Na sua opinião, como gestor da cadeia de suprimentos de uma instituição de saúde, qual seria o fornecedor ideal? Quais seriam os pré-requisitos? Como resposta, você poderia mencionar aquele fornecedor que tem um bom suporte técnico de pós-venda, que fornece respostas rápidas às solicitações e demandas, que pratica os melhores preços, que tem o melhor conhecimento do setor de atuação, que tem boas referências acerca do produto ou serviço comercializado ou que tem uma capacidade de customização de seus produtos. Na verdade, todos esses critérios são fundamentais na escolha, na seleção e na homologação de fornecedores — aliás, selecionar e homologar fornecedores pode parecer mais fácil do que você pensa.



Fique atento

Os critérios para avaliar fornecedores não estão restritos àqueles que fornecem apenas produtos, mas aos que prestam serviços também. É possível estabelecer critérios para implementar um programa de avaliação de desempenho para serviços vinculado, inclusive, aos resultados entregues. A esse processo chamamos de **acordos de níveis de serviço**, também conhecidos como **SLA** (*service level agreement*). Na gestão pública, é conhecido como **Instrumento de Medição de Resultados (IMR)** e é utilizado para avaliar serviços nas instituições públicas de saúde.

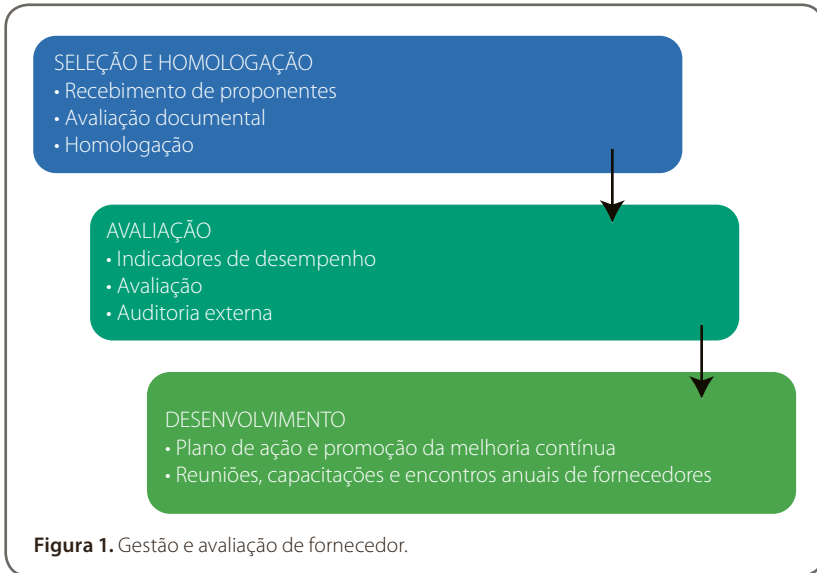
Para Porter e Teisberg (2007, p. 244), “[...] os fornecedores de produtos médicos, tecnologia e serviços desempenham um papel vital no valor da prestação de serviços de saúde e na inovação na prática da assistência à saúde”. Partem deles, na maioria das vezes, soluções mais viáveis e rentáveis para as instituições de saúde, como, por exemplo, o VMI (*vendor management inventory*), em que os fornecedores gerenciam os estoques dos seus clientes.

O processo parte da necessidade de repor determinado produto, quando seu pedido é aprovado e enviado ao fornecedor. Sobre isso, Barbieri e Machline (2017, p. 93) afirmam que “[...] quanto mais lento para resolver essas questões, maior será o prazo de espera e, consequentemente, a necessidade de manter estoques elevados para não deixar de atender à demanda”. Assim, os fornecedores selecionados e homologados por cada instituição de saúde precisam compreender que esse processo é compartilhado e que sua continuidade dependerá de uma avaliação sistemática e contínua.

Mas afinal, qual a importância de manter um processo padronizado para a seleção de fornecedores? O processo de **acreditação hospitalar**, por exemplo, preconiza que as instituições que desejem dar ênfase à qualidade precisam assegurar um “[...] gerenciamento dos critérios de seleção e de avaliação de fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos e serviços de acordo com os requisitos de segurança” (BRASIL, 2003). A acreditação, no modelo da Organização Nacional de Acreditação (ONA), dispõe essa exigência já em seu Nível 1, ou seja, o nível inicial, mas não menos importante, relacionado à segurança do paciente. No Nível 2, a ONA dá ênfase ao processo de melhoria contínua dos processos e à gestão de riscos e, no Nível 3, dá ênfase aos resultados mensurados por indicadores de desempenho.

Por isso, os hospitais e demais instituições de saúde investem em programas de avaliação e gestão de fornecedores e no monitoramento de riscos. Nesses programas, normalmente, os hospitais definem uma comissão para gerenciar os fluxos e os processos junto aos fornecedores. Como afirma Salu (2013, p. 151), “os departamentos de compras mais estruturados mantêm setores especializados separados para cadastro e habilitação de fornecedores, gestão das contratações e gestão de contratos”.

Dessa forma, a comissão tem como finalidade avaliar os fornecedores que impactam o processo de satisfação, qualidade e segurança do paciente por meio da seleção, cadastro e homologação de fornecedores; da avaliação de indicadores de desempenho dos fornecedores; do desenvolvimento de fornecedores nas tratativas de melhoria contínua; e da suspensão e desomologação de fornecedores, caso haja necessidade. Visualize a divisão dessas etapas na Figura 1.



Exemplo

Você pode estar se perguntando qual é a relação desses programas de avaliação de fornecedores com os custos, correto? Então vamos ver um exemplo.

Um hospital que deseja contratar um fornecedor, entender suas necessidades e dificuldades, ajudá-lo a estabelecer planos de melhoria, acompanhar e monitorar seus resultados, poderá otimizar processos internos e racionalizar custos por meio do fortalecimento de parcerias. Um fornecedor estratégico e parceiro para o hospital raramente atrasará entregas, ou ainda, praticará preços acima do mercado.

Porter e Teisberg (2007, p. 27) afirmam que: “Fornecedores de produtos, tecnologia e serviços médicos desempenham papéis vitais no próprio atendimento e nas inovações adotadas no atendimento à saúde. Eles são com frequência apontados como os principais culpados pelos aumentos de custo”.

Fica clara a relação com os custos? O processo de seleção e homologação de fornecedores propicia parceria e relacionamento; identificação com os propósitos e resultados do hospital; redução no custo total de aquisição (ciclo de compras e estoques); mitigação de riscos em relação à satisfação e segurança do paciente; aumento do poder de barganha em negociação; garantia da qualidade dos produtos e serviços; promoção da melhoria contínua do fornecedor; e garantia da sustentabilidade da cadeia de suprimentos e da logística hospitalar.

Os **critérios para a seleção dos fornecedores** são os mais variados, pois dependem do tipo da relação que a instituição de saúde pretende estabelecer com seu parceiro. Portanto, devem ser escolhidos os que mais se adequam aos interesses e resultados da instituição. Você certamente encontrará instituições definindo critérios específicos e padronizados na seleção de fornecedores e outras não, ou ainda, instituições atribuindo pesos diferentes na escolha de um mesmo critério.

Quais seriam estes critérios? Barbieri e Machline (2017, p. 143–144) relacionam alguns critérios que podem ser adotadas pelas cadeias de suprimentos das instituições de saúde, como:

Assistência técnica; atendimento às compras de emergência; atendimento às normas trabalhistas; capacidade de inovação; devoluções de produtos vencidos; flexibilidade para incorporar mudanças nas condições iniciais do pedido; nível de atendimento; pontualidade nas entregas anteriores; prazo de entrega; prazo de pagamento; preço; prestação de informações durante o processo de compra; qualidade; reputação do fornecedor; responsabilidade socioambiental; saúde financeira; conformidade com a legislação de defesa do consumidor; licenciamentos e das demais exigências ambientais; registros nos órgãos competentes no caso de medicamentos, OPME, equipamentos individuais de proteção, saneantes e alimentos processados.

Outra importante ferramenta para auxiliar o processo de seleção de fornecedores nas instituições de saúde é a adoção da classificação ABC e XYZ, que você pode ver na Figura 2, para as fontes de fornecimento e abastecimento. A classificação ABC é uma das mais importantes ferramentas gerenciais na etapa de programação e classifica os itens ou fornecedores de acordo com sua importância ou potencial financeiro. A classificação XYZ é utilizada para identificar as criticidades dos produtos e, por conseguinte, identificar quem são os fornecedores críticos do hospital.

Classificação ABC (financeiro)		Classificação XYZ (cliente)	
A	Itens alto consumo (R\$)	X	Itens baixa criticidade
B	Itens médio consumo (R\$)	Y	Itens média criticidade
C	Itens baixo consumo (R\$)	Z	Itens alta criticidade

Figura 2. Classificação ABC e XYZ.

Considerando o princípio da eficiência, a metodologia empregada na pesquisa de preços levará em conta o risco da compra, baseado na sua relevância material. No caso de compras com muitos itens, a exemplo dos medicamentos, a metodologia da pesquisa de preços poderá ser definida com base na aplicação dessa classificação. Com a adoção da classificação ABC e XYZ, os itens do grupo “A” e “Z” recebem tratamento especial, mais rigoroso, com máxima amplitude de fontes pesquisadas e tratamento estatístico apropriado, enquanto o grupo “B” e “Y” receberá tratamento intermediário e o grupo “C” e “X” será tratado de modo simplificado.

A classificação ABC é analisada pela perspectiva financeira e pode ser assim parametrizada:

- **Classe A:** 80% dos itens de maior consumo.
- **Classe B:** 15% dos itens de maior consumo.
- **Classe C:** 5% dos itens de maior consumo.

A classificação XYZ é analisada pela perspectiva crítica e pode ser assim parametrizada:

- **Classe X:** baixa criticidade — nenhum/pouco impacto nas atividades da instituição.
- **Classe Y:** média criticidade — impacto na área administrativa da instituição.
- **Classe Z:** alta criticidade — impacto na área assistencial da instituição.

Para estabelecer esses critérios, é importante a participação ou a nomeação de comissões de padronização, de preferência multidisciplinares (atividade fim e atividade meio), para cada grupo de produtos e medicamentos a serem padronizados. Essas comissões geralmente são denominadas Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e Comissão de Padronização de Material (CPM). Elas podem, inclusive, discutir a identificação e qualificação de fornecedores críticos, assim como o controle de compras de urgência e medicamentos não padronizados.

3 Gestão e avaliação de fornecedores

Como visto, após definir as fontes de fornecimento e abastecimento e selecionar os fornecedores em potencial, as instituições de saúde precisam assegurar a continuidade do processo, promovendo a avaliação dos fornecedores, visando ao seu desenvolvimento. Denominamos esse processo de gestão e avaliação de fornecedores.



Saiba mais

Há diversas metodologias para avaliar os fornecedores na cadeia de suprimentos, nas quais, o mais importante, é estabelecer a política e a ferramenta de avaliação, visando a assegurar o processo de gestão, avaliação e desenvolvimento de fornecedores. Nesse sentido, a entrevista concedida por Hélio Meirim ao programa *Logística em Movimento*, do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, esclarece algumas metodologias e ferramentas que podem auxiliar no processo de avaliação de fornecedores. A entrevista “avaliação de fornecedores” está disponível no YouTube, no canal CRA-RJ.

O **processo de avaliação** de fornecedores tem a finalidade de avaliar se o nível de resultado pretendido com a contratação foi alcançado. Se esse resultado não foi satisfatório, o intuito é estabelecer um plano de melhorias, buscando o desenvolvimento dos fornecedores.

Para Andrew Cox (2004, p. 349, *apud* GRANT, 2013, p. 57), a avaliação de fornecedores permite realizar “investimentos dedicados ao relacionamento e à criação de vínculos técnicos [...] com o intuito de criar novas ofertas de produtos e serviços nas quais o comprador assume a liderança na determinação de alvos mais exigentes para funcionalidade e custos”. Essa avaliação é realizada mediante critérios preestabelecidos, no planejamento da contratação, e esses critérios são mensurados periodicamente. O resultado da avaliação será objeto de análise crítica por parte do hospital, registrando as não conformidades, recebendo devolutivas formalizadas e os planos de ação corretivos e preventivos, devendo ainda acompanhar o cumprimento dos resultados pretendidos.

As avaliações de fornecimento serão realizadas a cada processo de recebimento, ou seja, a cada recebimento pelo estoque (almoxarifado, farmácia, entre outros), o fornecedor será avaliado mediante critérios preestabelecidos de compras (tempo de entrega; não conformidade; facilidade de pagamento; regularidade empresarial) e de estoques (transporte; conformidade da nota fiscal; produtos dentro das especificações da qualidade; pontualidade da entrega; atendimento do pedido).

Visualize, na Figura 3, como poderia ser composta a nota final da avaliação do fornecedor de determinada instituição de saúde, utilizados os critérios que acabamos de ver.



Figura 3. Avaliação de fornecedor.

O **processo de desenvolvimento** consiste no relacionamento e na busca da melhoria contínua da relação entre o hospital e seus fornecedores e prestadores de serviço. Isso ocorre por meio de um sistema de gestão de relacionamento da cadeia de suprimentos, composto por interações das partes; reuniões; avaliações; auditorias externas; encontros anuais de fornecedores; treinamentos e planos de ação, visando ao estabelecimento de estratégias; e resolutividades de não conformidades — tudo isso em um canal aberto e rápido de informação. Nesse canal de comunicação, inclusive, o fornecedor terá um fluxo aberto e rápido de informação, com a possibilidade de ajustar calendário de entrega, produção e envio de necessidades, minimizando estoques e custos, por exemplo.

Mas qual é a relação do desenvolvimento de fornecedores com os custos hospitalares? O foco do desenvolvimento de fornecedores é buscar traduzir uma simples adesão do fornecedor em uma vantagem competitiva para a instituição de saúde, em etapas sequenciais, conforme você pode ver na Figura 4.

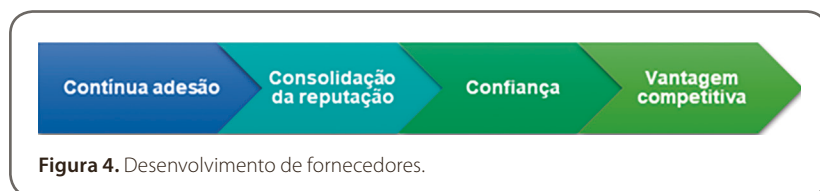


Figura 4. Desenvolvimento de fornecedores.

Para Grant (2013, p. 58), “[...] relacionamentos em logística são considerados uma fonte de vantagem competitiva para as empresas determinarem seu futuro com compradores e fornecedores em um mundo cada vez mais complexo”. A vantagem competitiva a que o autor se refere é adquirida pelo relacionamento que os fornecedores proporcionam à logística hospitalar em algumas condições especiais de mercado, como preços tabelados e prioridade nas entregas. Com um parceiro estratégico, por exemplo, é oportuno celebrar contratos de fornecimento, adquirindo produtos em quantidade, minimizando o custo unitário — principalmente, porque, no cenário dos hospitais brasileiros, “[...] as compras pontuais são as de maior frequência, representando geralmente 90% das aquisições” (SALU, 2013, p. 151), o que por sua vez, aumenta o valor unitário do produto.

Entretanto, depois de esgotadas as possibilidades e persistidas as não conformidades da relação comercial entre o fornecedor e o hospital, o processo é avaliado pela comissão. Essa etapa consiste em avaliar os registros de não conformidades e a integridade do processo, visando a suspender ou cancelar o cadastro e homologação do fornecedor. Algumas causas podem provocar a desomologação do fornecedor, isoladamente ou em conjunto. Entre as prováveis causas da desomologação, podemos citar as seguintes:

- inadimplemento reiterado do prazo de entrega;
- registros constantes de notificações de farmacovigilância e tecnovigilância na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);
- desacordo com os requisitos legais relacionados à sua atividade;
- apuração de não conformidades técnicas que comprometam a integridade e segurança do paciente;
- não apresentação de documentos técnicos e legais validados ou prazo de vigência expirado que comprometam a segurança do paciente;
- resultado insatisfatório e sem resolutive/devolutiva.



Saiba mais

Diante das seis prováveis causas de desomologação de um fornecedor, que você acabou de ver, qual delas pode causar maior impacto nos custos do hospital e por quê? Você acredita que o reiterado atraso na entrega de medicamentos pode influenciar nos custos hospitalares?

Uma boa forma de responder a essas questões é conhecendo os critérios adotados por grandes hospitais. Para isso, sugerimos a leitura do critério da pontualidade adotado pelo Hospital Albert Einstein, de São Paulo, disposto em seu *Manual do Fornecedor Einstein*. Para encontrá-lo, pesquise “Fornecedor Einstein” em seu navegador da internet, acesse o site da instituição e faça *download* do manual.

Grant (2013, p. 57) afirma que a “avaliação também provê uma estimativa de risco para o comprador”, por isso, para algumas instituições de saúde, uma alternativa é implantar planos de contingência que atuem como controle de recuperação e atenuante da inconformidade ou falha evidenciada. Esses planos devem ser executados após a ocorrência do risco identificado no planejamento da contratação, visando a diminuir o impacto da ocorrência e mitigar as consequências.

Por fim, o relacionamento com os fornecedores exige a:

[...] disposição de um fornecedor e de um comprador de sacrificar vantagens a curto prazo em favor de ganhos de longo prazo [...], incluindo reduções de custos, compartilhamento de risco, criatividade compartilhada, entendimento das desistências do comprador e o potencial para novos negócios (GRANT, 2013, p. 60).



Exemplo

Um exemplo de plano de contingência é contratar o mesmo item com dois fornecedores distintos. Digamos que o medicamento Filgrastim, apresentação: 300 mcg, tipo uso: injetável (0268118), foi adquirido no município de São Sebastião, SP, em 19/09/2019, pelo valor de R\$ 48,00 (750 unidades) de um fornecedor, e por R\$ 54,25 (250 unidades) de outro fornecedor (BRASIL, 2020). Esse é um exemplo típico dos planos de contingência para evitar riscos nos suprimentos e, consequentemente, onerar os custos da logística hospitalar. Entretanto, esse tipo de plano de contingência apenas é possível, do ponto de vista legal, se ficar assegurada que a solicitação do item mais caro é por contingência, e não de rotina.

Neste capítulo, você estudou as fontes de fornecimento e abastecimento da cadeia de suprimentos nas instituições de saúde, como elas selecionam e homologam os fornecedores aprovados e como eles são avaliados de forma sistemática. Você viu também que, além de proporcionar benefícios à segurança do paciente (garantindo que o suprimento seja entregue no tempo correto, na quantidade certa e no local correto), o processo de gestão e avaliação de fornecedores também visa a auxiliar o fornecedor a melhorar e desenvolver seus processos internos, aumentar seus ganhos e reduzir seus custos, alcançando resultados mutuamente benéficos com seus clientes, as instituições de saúde.



Referências

BALLOU, R. *Gerenciamento da cadeia de suprimentos/Logística empresarial*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BARBIERI, J. C.; MACHLINE, C. *Logística hospitalar: teoria e prática*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

BOWERSOX, D. J. et al. *Gestão logística da cadeia de suprimentos*. Porto Alegre: Bookman, 2014.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Organização Nacional de Acreditação (ONA). *Manual de acreditação das organizações prestadoras de serviços hospitalares*. 4. ed. Brasília, DF: ANVISA; ONA, 2003. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/qualidade/Manual%20de%20Acreditacao%20das%20Org.%20Prestadoras%20de%20Serv.%20Hospitalares.pdf>. Acesso em: 10 maio 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Banco de preço em saúde*. Brasília, DF, 2020. Sistema online. Disponível em: <http://bps.saude.gov.br/>. Acesso em: 10 maio 2020.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Acórdão 1.419*. Plenário. Relator: Augusto Nardes. Data da sessão: 19 jun. 2019. Brasília, DF, 2019b. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1419%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e30bbaa0-8733-11ea-8f61-1534b451f17e. Acesso em: 10 maio 2020.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Acórdão 13.053*. 2ª Câmara. Relator: Augusto Nardes. Data da sessão: 03 dez. 2019. Brasília, DF, 2019a. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A13053%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e30bbaa0-8733-11ea-8f61-1534b451f17e. Acesso em: 10 maio 2020.

GRANT, D. B. *Gestão de logística e de cadeia de suprimentos*. São Paulo: Saraiva, 2013.

PORTER, M. E.; TEISBERG, E. O. *Repensando a saúde: estratégias para melhorar a qualidade e reduzir custos*. Porto Alegre: Bookman, 2007.

SALU, E. J. *Administração hospitalar no Brasil*. Barueri, SP: Manole, 2013.

**Fique atento**

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS